

Zepbound (tirzépatide) — Information patient

Objectif du traitement

Zepbound est utilisé pour favoriser la perte de poids en diminuant l'appétit, en augmentant la sensation de satiété et en ralentissant la vidange de l'estomac. Il agit sur deux récepteurs hormonaux (GIP et GLP-1) et réduit aussi les fringales et l'attrait pour les aliments sucrés et gras.

Nature du traitement et coût

Le traitement est généralement chronique afin de maintenir les bénéfices sur le poids. Il s'agit d'une injection sous la peau une fois par semaine, à l'aide d'un stylo multidose contenant 4 doses (un stylo par mois).

Le coût sans assurance est d'environ 300 à 540 \$ par mois selon la dose. Il n'est pas couvert par la RAMQ ni les régimes publics; environ un régime privé sur trois le couvre — vérifiez auprès de votre assureur. Le programme du fabricant (myZepbound) peut réduire le coût pour les patients admissibles.

Aucune version générique du tirzépatide n'est attendue avant plusieurs années.

Effets secondaires fréquents (attendus)

Ces effets sont généralement transitoires et surviennent surtout au début ou lors de l'augmentation des doses.

Digestifs :

- Nausées : 25–29 %
- Diarrhée : 19–23 %
- Constipation : 11–17 %
- Vomissements : 8–13 %
- Douleurs abdominales : 9–10 %
- Dyspepsie : 9–10 %
- Rots (éructations) : 4–6 %
- Reflux : 4–5 %
- Gaz et ballonnements : 3–4 %

Autres :

- Réactions au site d'injection : 6–8 %
- Fatigue : 5–7 %
- Étourdissements : 4–6 %
- Perte de cheveux légère à modérée : 4–5 %
- Augmentation de la lipase (+34 % en moyenne) et de l'amylase (+23 %) — habituellement sans conséquence
- Légère augmentation du pouls au repos (~3 battements/minute en moyenne)
- Hypoglycémie : ~4 % si diabète traité (jusqu'à 10 % en combinaison avec une sulfonylurée — votre médecin pourrait réduire vos autres médicaments du diabète)

Conseils pour améliorer la tolérance

- Manger lentement et en petites quantités
- Éviter les repas gras au début
- Respecter la montée progressive des doses
- Maintenir une bonne hydratation (particulièrement important : la déshydratation peut affecter les reins)

Effets rares mais importants

Pancréatite : complication rare mais potentiellement grave

La pancréatite est un effet secondaire rare du Zepbound (environ 0,2 % dans les études). Consultez rapidement en cas de douleur sévère et persistante à l'abdomen ou au dos, avec ou sans vomissements.

Maladie de la vésicule biliaire (~1–2 %)

Calculs biliaires et inflammation de la vésicule, associés à la perte de poids rapide. Douleur intense à l'abdomen, à l'épaule droite ou entre les omoplates; consultez immédiatement si la douleur s'accompagne d'un teint de peau qui jaunit ou d'une fièvre avec frissons.

Déshydratation et reins

Les nausées, vomissements ou diarrhées importants peuvent mener à une déshydratation et, rarement, à une insuffisance rénale aiguë (0,5 %). Buvez suffisamment de liquides.

Rétinopathie (chez patients diabétiques)

Peut survenir si amélioration rapide de la glycémie. Symptômes visuels à surveiller.

Cancer de la thyroïde (très rare, non démontré chez l'humain)

Signal observé chez les animaux. Éviter si antécédent personnel/familial de carcinome médullaire thyroïdien ou MEN2.

Autres effets rares

Ralentissement sévère de la vidange de l'estomac (gastroparésie) ou blocage intestinal; réactions allergiques graves (enflure du visage ou de la gorge, difficulté à respirer); changements d'humeur ou idées noires — rapportés avec les médicaments de perte de poids : consultez sans tarder si vous ou vos proches remarquez un changement inhabituel.

Précautions particulières

- **Contraceptifs oraux** : leur efficacité peut être temporairement réduite. Utilisez une méthode non orale ou ajoutez une méthode barrière (condom) pendant les 4 semaines suivant le début du traitement et chaque augmentation de dose.
- **Grossesse et allaitement** : contre-indiqué. Cessez le traitement au moins 1 mois avant une grossesse planifiée.
- **Chirurgie ou sédation** : mentionnez que vous prenez Zepbound avant toute intervention nécessitant une anesthésie (l'estomac se vide plus lentement).

Quand consulter rapidement

- Douleur abdominale sévère persistante
- Vomissements importants ou signes de déshydratation (étourdissements, urines foncées)
- Douleur intense au ventre avec teint jaune ou fièvre et frissons
- Troubles visuels
- Masse au cou ou difficulté à avaler
- Réaction allergique (enflure du visage ou de la gorge, difficulté à respirer)
- Changement inhabituel de l'humeur ou idées noires

Différences par rapport au Wegovy

- **Mécanisme** : Zepbound agit sur deux récepteurs (GIP et GLP-1), alors que Wegovy agit sur un seul (GLP-1).
- **Efficacité** : la perte de poids moyenne est plus importante avec Zepbound — environ 19 à 21 % du poids initial après 72 semaines aux doses de 10–15 mg (environ 1 patient sur 2 perd 20 % ou plus à la dose maximale), contre environ 15 % avec Wegovy. Chez les personnes diabétiques, la perte est d'environ 13 à 15 %.
- **Mode de prise** : même fréquence (1 injection par semaine), mais le stylo est différent — un stylo multidose de 4 doses par mois.
- **Effets secondaires** : profil globalement semblable, dominé par les effets digestifs; les réactions au site d'injection et une perte de cheveux légère sont un peu plus souvent rapportées avec Zepbound.
- **Interaction propre au Zepbound** : efficacité temporairement réduite des contraceptifs oraux (voir précautions ci-haut) — cette précaution ne s'applique pas au Wegovy.
- **Coût** : ordre de prix comparable (300 à 540 \$/mois selon la dose), mais aucun générique de tirzépatide n'est attendu avant plusieurs années, alors que des versions génériques du sémaglutide (Wegovy) sont disponibles depuis l'été 2026 et peuvent réduire les coûts.

- **Recul** : commercialisé plus récemment au Canada (2025).

Suivi recommandé

Un suivi médical régulier est nécessaire pour ajuster la dose, surveiller la tolérance et évaluer les bénéfices. Si vous êtes diabétique, une surveillance de la glycémie est également recommandée.